

可控性皮肤尿流改道（印第安纳储尿囊）

患者须知 · 内置储尿囊，通过导尿管自行排尿 — 无需外接集尿袋

WARWIKI

可控性皮肤尿流改道是用您自身肠道制成的体内储尿囊，尿液储存在体内，通过腹部一个小型防漏开口（造口，通常位于脐部）引出。您无需佩戴集尿袋，每天数次将导尿管插入造口排空储尿囊即可。印第安纳储尿囊是最常见的术式。

关于这项手术

手术截取一段**大肠和小肠**，在腹腔内重塑为低压**储尿囊**；来自肾脏的输尿管引流其中。一条内置**单向瓣膜**的短通道被引至皮肤 — 通常在**肚脐**处 — 形成一个小而平坦的造口，导尿间期保持干燥。

- 每隔**4~6小时**插入导尿管排空储尿囊。
- 定期**冲洗（灌洗）**储尿囊以清除黏液。
- **无需集尿袋** — 造口处贴一小块护垫或敷料即可。

本术式适合不愿佩戴集尿袋、无法或不愿行新膀胱手术，且能**可靠完成自我导尿**的患者 — 需要手部稳定、视力良好，或有看护者协助。

安全吗？

这是成熟的可控性改道方案。与回肠通道相比，手术时间更长、创伤更大，且需终身导尿。风险包括：手术相关风险（出血、感染、吻合口漏），导尿困难或造口狭窄/渗漏（有时需小手术修复），储尿囊结石、黏液、泌尿系感染，以及需长期随访监测的电解质/维生素/肾功能变化。

名词解释

可控性尿流改道

一种不会漏尿的尿液转流方式 — 由您控制排尿时机。

印第安纳储尿囊

最常见的可控性储尿囊，由右半结肠和小肠构建。

储尿囊

由肠道制成、储存尿液的体内囊袋。

造口

皮肤上的小开口（通常在脐部），供导尿管插入。

导尿

将细导尿管经造口插入以排空储尿囊。

灌洗

向储尿囊注水冲洗以清除黏液。

输尿管

将尿液从肾脏输送至储尿囊的管道。

黏液

肠道分泌的滑性液体，定期清除是日常护理的一部分。

会疼吗？ 手术在全身麻醉下进行，术中无感觉。术后会有腹部酸痛，肠道需数日才能“苏醒”。您醒来时储尿囊内留有引流管（及软支架管），约3~4周后拔除，期间需定期冲洗以清除黏液。大多数患者住院约5~8天。

如何准备（术前）

- 手术采用**全身麻醉** — 遵守所有术前指导（禁食、按医嘱停用抗凝药）。可能需要**肠道准备**。
- 医疗团队将规划**造口位置**（通常在脐部），并确认您或看护者能够**终身完成导尿**。
- **戒烟**，并提前安排术后居家照护。

请提前告知您的医疗团队，如果您：

- 正在服用**抗凝药**，或目前存在感染
- 有**肠道疾病**、肾脏问题，或影响导尿的**手部或视力障碍**

手术过程

- 1 您在麻醉下入睡，同时给予抗生素。
- 2 截取一段肠道，剩余肠道重新吻合。
- 3 截取的肠道被重塑为储尿囊，带单向瓣膜的可导尿通道引至皮肤形成造口。
- 4 输尿管与储尿囊吻合；放置引流管和软支架管，待愈合。

之后

- 约**5~8天**后出院，携带**储尿囊引流管**约**3~4周**；定期冲洗以清除黏液。
- 拔管、储尿囊愈合后，每隔**4~6小时**经造口**导尿一次**，并灌洗清除黏液。
- 造口保持**干燥** — 贴小护垫或敷料覆盖（无需集尿袋）。
- 黏液属正常现象；多喝水；终身随访（维生素B12、储尿囊复查）。约**6周内避免重体力劳动**。

出现以下情况请立即联系您的医疗团队：

- **无法插入导尿管或导不出尿液** — 储尿囊可能过度充盈，须紧急引流
- 发热或畏寒
- 腹痛剧烈、呕吐，或**无排气排便**
- 大量出血或血凝块堵塞导尿管，或伤口红肿渗出

需要记住的三件事

1. 可控性皮肤（印第安纳）储尿囊将尿液储存在体内，通过小型防漏造口用导尿管排尿 — 无需集尿袋。
2. 终身每隔4~6小时经造口导尿并灌洗清除黏液 — 需要手部稳定、视力良好（或有协助者）。
3. 术前禁食并完成肠道准备，戒烟，安排居家照护。若无法导尿或导不出尿，须立即就医。